РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТУДЕНТА

WORKBOOK

13 ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ОНИХОЛИЗИСА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА МАСТЕРА

Автор курса: Ольга Серебрянская — подолог, преподаватель, основатель учебного центра подологии в Праге

1. ЧТО ТАКОЕ ОНИХОЛИЗИС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Онихолизис — отслаивание ногтевой пластины от ногтевого ложа. Звучит банально просто, но за ним стоит фундаментальная теория и как минимум **13 причин** появления этой проблемы. От знания и понимания причин — зависит тактика мастера.

ЗАПОЛНИТЕ: СФОРМУЛИРУЙТЕ РАЗЛИЧИЕ

ГРУППА ПРИЧИН	ИСТОЧНИК	ВАША ФОРМУЛИРОВКА: В ЧЁМ СУТЬ
Эндогенные внутренние факторы	Системные заболевания, нарушения обмена, приём лекарств	
Экзогенные внешние факторы	Травма, обувь, химия, инфекция, ожоги, стресс	

13 ПРИЧИН

5 эндогенных + 8 экзогенных — их нужно уметь различать в кабинете за первые минуты приёма

ОДИНАКОВОЕ НАЗВАНИЕ

У разных клиентов онихолизис может выглядеть одинаково, но быть радикально разными проблемами

РАЗНАЯ ТАКТИКА

Эндогенный — работа в паре с врачом. Экзогенный — мастер работает самостоятельно

НЕ ВСЕГДА СПИЛИВАТЬ

Не каждый онихолизис НАДО убирать. Сначала — причина, потом — решение

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

? Почему мастер, не различающий эндогенные и экзогенные причины, рискует навредить клиенту — даже если технически выполняет работу безупречно?

2. ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ (5)

Правило работы: эндогенная причина = мастер работает **в паре с врачом** и только по его «отмашке». Если вы не мастер спорта по фигурному катанию по тонкому льду — в одиночку здесь не работать.

5 ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ · ЗАПОЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ФАКТОР	ПРИМЕРЫ / МЕХАНИЗМ	ЧТО НАБЛЮДАЕМ НА НОГТЕ
Системные заболевания	Псориаз, экзема, заболевания щитовидной железы	
Нарушения кровообращения	Диабетическая стопа, облитерирующий атеросклероз, ХВН	
Дефицит микроэлементов	Недостаток железа, цинка → коилонихия («ложкообразные ногти»)	
Сахарный диабет	Нарушение микроциркуляции и нейропатия	
После химиотерапии / антибиотиков	Токсическое поражение матрикса, снижение трофики	

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР: КОИЛОНИХИЯ

Коилонихия (Koilonychia) — тонкие, ломкие ногти, теряющие выпуклость и становящиеся вогнутыми, как ложка. Частое проявление хронической железодефицитной анемии. **Рекомендация клиенту:** проверить гемоглобин и ферритин; улучшение ногтей — через **4–18 месяцев** (ногти ног растут медленнее).

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

? Клиент приходит с коилонихией. Какие вопросы вы задаёте в анамнезе и к какому врачу направляете?

3. ЭНДОГЕННЫЕ-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ИАТРОГЕННЫЕ

ПОДНОГТЕВОЙ ЭКЗОСТОЗ

Подногтевой экзостоз — аномальный рост кости в области дистальной фаланги, который механически **поднимает ногтевую пластину снизу**, вызывая её хроническую деформацию и последующий онихолизис.

? Остеофит vs экзостоз: в чём разница? Сформулируйте своими словами.

ИАТРОГЕННАЯ ЦЕПОЧКА · ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ

Пример: клиентка получает длительную гормонотерапию кортикостероидами. Выстройте полную цепочку причинно-следственных связей:

Эндокринная патология + длительная гормонотерапия
↓
[ ]
↓
[ ]
↓
Онихолизис

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ · ЗАПОЛНИТЕ

ЕСЛИ ПЕРВОПРИЧИНА	ТИП ФАКТОРА	ВАША ТАКТИКА
Болезнь → лечение → деформация ногтя	**Эндогенный**	
Травма или грибок	**Экзогенный**	

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС

! Клиентка после курса химиотерапии (рак молочной железы) — онихолизис на нескольких ногтях. Первичная причина, вторичное следствие, тактика:

4. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ (8)

Правило работы: экзогенная причина = мастер работает **самостоятельно**, но ВАЖНО сначала правильно выявить причину, а потом — решать проблему. Не каждый онихолизис НАДО спиливать.

8 ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ · ОТМЕТЬТЕ ЗНАКОМЫЕ

№	ФАКТОР	ВАШ ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
1	Травматизация (гематомы, механическое повреждение, длительное давление, неудобная обувь, неправильный педикюр)	
2	Биомеханические нарушения (деформации стопы и пальцев)	
3	Контакт с агрессивными химическими веществами (лаки, средства для снятия гель-лака, детергенты)	
4	Инфекционные агенты (грибковая или бактериальная инфекция)	
5	Химический и термический ожоги	
6	Сильный стресс	
7	После воспалительных процессов (вросший ноготь, панариций, воспаления боковых валиков)	
8	Гиперкоррекция (неправильно подобранная коррекционная система)	

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

? С каким экзогенным фактором вы сталкиваетесь чаще всего? Что обычно пропускают коллеги при сборе анамнеза?

5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ И ТАКТИКА

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ · ЗАПОЛНИТЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

ЧТО ВИДИМ	О ЧЁМ ЭТО МОЖЕТ ГОВОРИТЬ	ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Потемневший ноготь утолщённый, ломкий	Диабет, нарушение кровоснабжения, нейропатия	
Деформированный / поражённый ноготь	Возможный грибок → онихомикоз	
Ноготь с утолщением + возможная грибковая инфекция	Артериальная болезнь, периферический диабет	

РЕШАЮЩАЯ РАЗВИЛКА · ТАКТИКА МАСТЕРА

Э Если причина **эндогенная** → _____

Э Если причина **экзогенная** → _____

> *«Не каждый онихолизис НАДО убирать (спиливать). Сначала — правильно выявить причину появления проблемы, а только потом решать саму проблему.»*

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМА

Отметьте, что вы уточнили у клиента **до начала работы**:

- ☐ Собран анамнез системных заболеваний (щитовидка, диабет, псориаз)
- ☐ Уточнён приём лекарств (гормоны, химиотерапия, антибиотики)
- ☐ Оценены уровень гемоглобина и ферритина при подозрении на коилонихию
- ☐ Осмотрена обувь и биомеханика стопы
- ☐ Исключён контакт с агрессивной химией за последние 1–2 месяца
- ☐ Исключены грибок и бактериальная инфекция
- ☐ Принято решение: работаю сам или направляю к врачу

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ: РЕФЛЕКСИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

БЛОК НАБЛЮДЕНИЙ

МОИ ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЛЕКЦИИ

1

2

3

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ

БЫЛО (ДО ЛЕКЦИИ)	СТАНЕТ (ПОСЛЕ)

ПЛАН НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ

✓ **Один конкретный шаг, который я сделаю в работе с клиентами уже на следующей неделе:**

МОИ ЗАМЕТКИ